

Université Saleh Boubnider
Faculté de médecine
Département de médecine

SYNDROMES DE LARVA MIGRANS

Dr Belattar.N

Année universitaire 2024/2025

Objectifs pédagogiques

- **Distinguer les deux sortes des syndromes de *larva migrans***
- **Connaître les différents aspects cliniques.**
- **Discuter du diagnostic devant un ensemble d'arguments.**
- **Planifier une prise en charge thérapeutique adéquate.**

Plan

- I. Introduction**
- II. Les syndromes de Larva migrans viscérale**
 - 1-Toxocarose**
 - 2-Anisakiase**
- III. Le syndrome de Larva migrans cutanée**

INTRODUCTION

Les syndromes de *larva migrans* (SLM):

Ensemble des symptômes provoqués par **les migrations** et **la survie** dans l'organisme de **larves de nématodes d'animaux** en **impasse parasitaire** chez l'homme.

- On distingue 2 sortes de SLM:
 - **Viscérale (SLMV)**
 - **Cutanée (SLMC)**

Le syndrome de Larva migrans viscérale

Ne sont traitées dans ce chapitre que la toxocarose (larva migrans viscérale stricto sensu) et l'anisakiose ou anisakidose (assimilée au syndrome de larva migrans viscérale), sans aborder les rares angiostrongyloïdose, gnathostomose...

1-TOXOCAROSE

I- Définition

Zoonose helminthique **cosmopolite**, correspondant à l'infestation de l'homme par les larves des **Ascaridés**:

- ✓ *Toxocara canis* du chien
- ✓ *Toxocara cati* du chat

1-TOXOCAROSE

II. Épidémiologie:

1-Agent pathogène:

1-1- Classification

E: Helminthes

S/E: Némathelminthes

C: Nématodes

F: Ascaridae

G: Toxocara

E: *T canis* +++

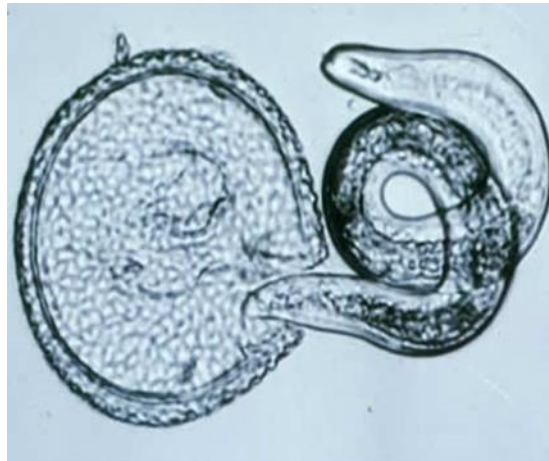
T cati +

I-TOXOCAROSE

1.2 Morphologie:

Ces parasites sont proches de l'ascaris humain.

Ils vivent dans l'intestin grêle de leur hôte naturel et mesurent entre 5 cm et 10 cm



I-TOXOCAROSE

2. Cycle évolutif:

Le cycle naturel est complexe, influencé par la sécrétion de certaines hormones (chiennes gravides)

Chez l'homme, l'infestation se fait par ingestion d'aliments souillés par des œufs

embryonnés, c'est surtout l'enfant qui se contamine en portant à la bouche ses mains salies par des déjections canines souillant les aires de jeux.

Après éclosion des œufs, les larves entreprennent une migration tissulaire mais, ne peuvent pas évoluer au-delà du stade **L2**.

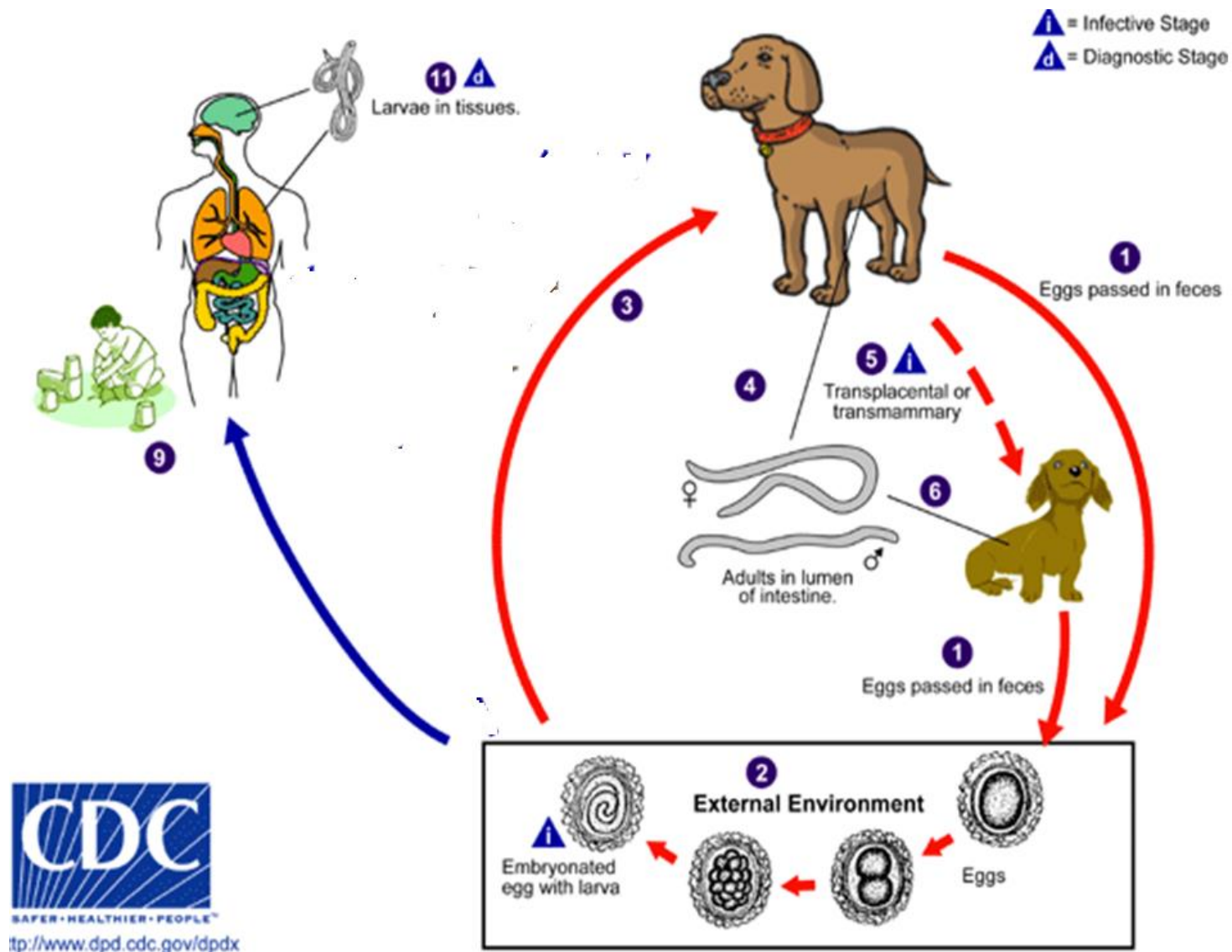


FIG2: Cycle évolutif de la toxocarose

I-TOXOCAROSE

3. Mode de contamination:

La contamination relevant du péril fécal canin, par ingestion d'œufs embryonnés.

C'est une pathologie surtout **enfantine**

- Contact étroit avec chiot.
- Bac de sable jardin public.
- Géophagie.
- Consommation des fruits et légumes souillés par les œufs.

I-TOXOCAROSE

II-Physiopathologie :

Les larves immobilisées dans les tissus génèrent un granulome inflammatoire riche en éosinophiles et sont responsables d'une symptomatologie polymorphe en rapport avec leur localisation (hépatique, oculaire, neurologique)

I-TOXOCAROSE

III- Clinique:

- Ça dépend fortement du **degré d'infestation** et de **la localisation des larves**.
- Les signes cliniques sont liés à la migration larvaire au niveau du **foie**, des **poumons** et parfois vers **d'autres viscères** (**toxocarose cérébrale** est rare), et l'œil (**Toxocarose oculaire**)
- Les plus fréquentes: l'asthénie, la fièvre, une hépato-splénomégalie, des symptômes pulmonaires, des manifestations cutanées (urticaire...), cardiaques ou neurologiques.

Des manifestations oculaires (uvéite souvent unilatérale), peuvent survenir à distance de la contamination.

- Parfois asymptomatique (formes mineures)

I-TOXOCAROSE

IV- Diagnostic:

- Les examens biologiques :

Une hyperéosinophilie importante parfois $>20\,000\text{ E/mm}^3$ puis elle diminue lentement en plusieurs années.

Une hyper gammaglobulinémie avec augmentation des IgE.

- Le diagnostic direct:

La visualisation de larves tissulaires exceptionnelle.

- Le diagnostic indirect:

La sérologie demeure le meilleur outil diagnostique.

Les techniques tendent à devenir de plus en plus spécifiques et l'importance des réactions croisées diminue (immunofluorescence indirecte, immuno électrophorèse, ELISA, western-blot...).

I-TOXOCAROSE

V- Traitement: délicat et difficile à évaluer

- Les antihelminthiques : réservés aux formes graves ou non améliorées par la mise en place d'une prophylaxie adaptée.
- **Diethylcarbamazine:** 4 mg / kg / jour, dose à atteindre progressivement
- **Albendazole :** 10 à 15 mg / kg / jour pendant 15 jours
- **Corticoïdes:** Si manifestations allergiques trop importantes ou localisation oculaire

I-TOXOCAROSE

VI- Prophylaxie:

- **Individuelle** : - Vermifugation des chiens et des chats adultes.
 - Déparasitage mensuel des chiots jusqu'à 6 mois d'âge
 - Lavage systématique des mains avant les repas, et après des jeux sur le sol
 - Prévention de la géophagie.
- **Collective** :
 - Éviction des chiens des parcs publics et des aires de jeux.
 - Suppression des bacs à sable publics ou renouvellement fréquent du sable.

2- ANISAKIASE

I- Définition

Une helminthiase communément appelée *maladie du ver du hareng* liée à la fixation sur la muqueuse gastrique ou intestinale de *larves vivantes* de nématodes de la famille des **Anisakidae** transmise par la consommation de **poison de mer** cru ou peu cuit.

Cette parasitose **cosmopolite**, fréquente au Japon (1 000 cas annuels), est retrouvée de façon sporadique en Europe et est essentiellement liée à la consommation de harengs (fumés ou marinés) ou de sushi.

2- ANISAKIASE

II. Épidémiologie:

1-Agent pathogène:

1-1- Classification

E: Helminthes

S/E: Némathelminthes

C: Nématodes

F:Anisakidae

04 genres (Homme): **Anisakis++**, **Contracaecum**, **Terranova**, **Phocanema**

2- ANISAKIASE

1.2 Morphologie:

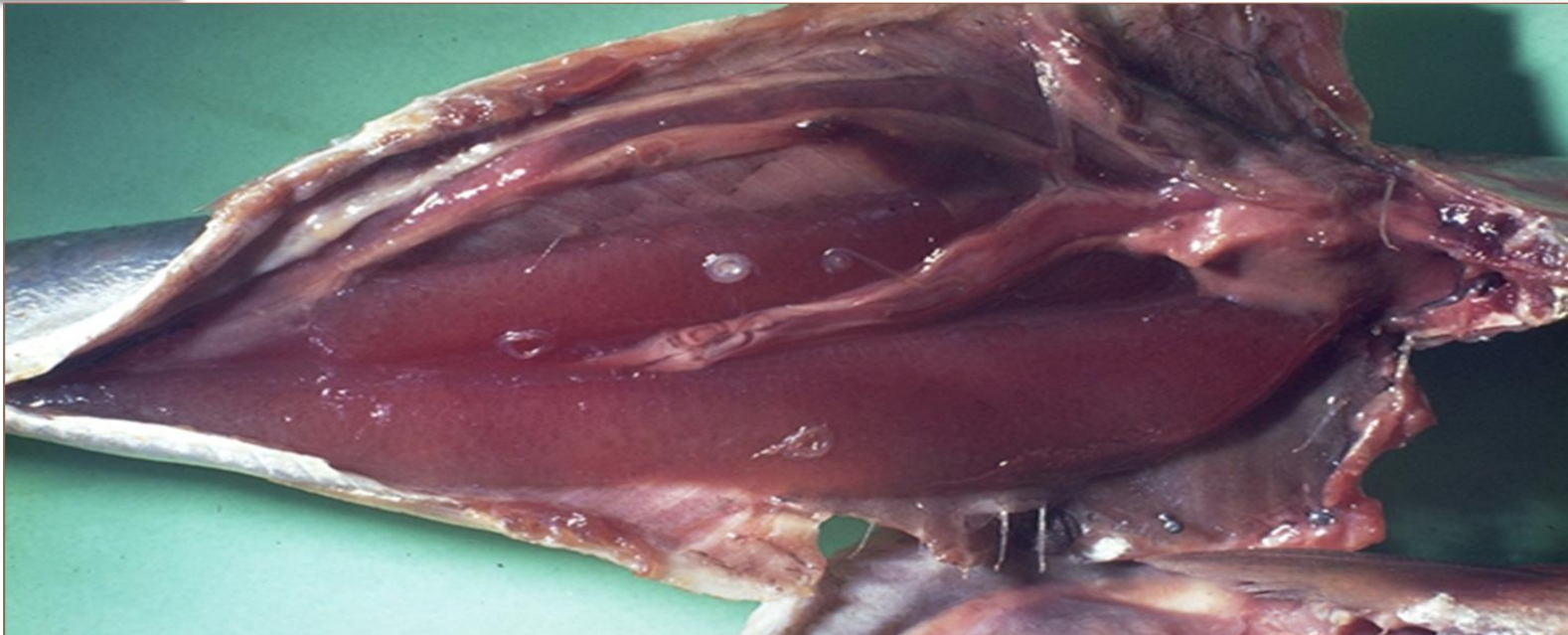
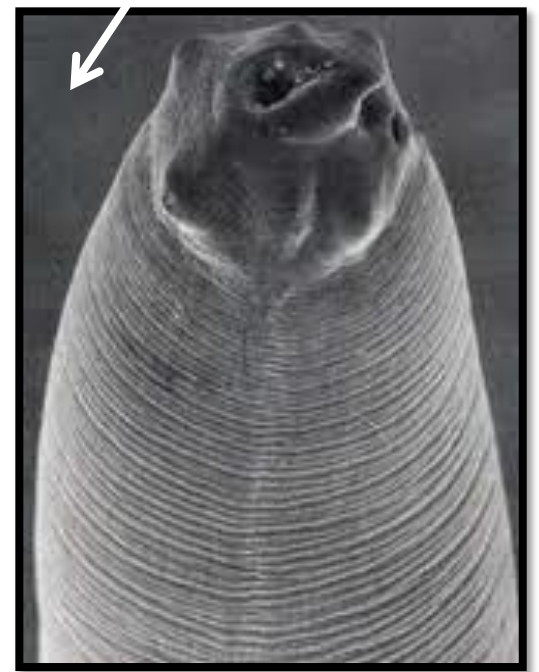
Les larves *d'Anisakis sp* se présentent comme des vers effilés (2 à 3 cm)aux deux bouts blancs et s'enroulent souvent sur elles même.





La larve L3 se distingue par la présence d'une dent cuticulaire située dans le pôle céphalique, non loin de la bouche

La larve L3 prélevée sur le poisson, mise dans l'eau → mobile



Larves anisakidae, enroulées en spirale et plaquées sur les gonades d'un poisson

2- ANISAKIASE

2. Cycle évolutif:

- Les nématodes adultes vivent dans **l'estomac** de leurs hôtes définitifs (animaux marins: baleines, dauphins, phoques, etc.).
- Les œufs éliminés avec leurs selles vont s'embryonner et éclore, libérant des larves de stade **L2**.
- Celles-ci sont absorbées par des crustacés et évoluent en **L3, stade infestant pour l'hôte définitif**.
- Très souvent un 2e hôte intermédiaire est nécessaire pour la poursuite du cycle (poisson, ...), la larve L3 se fixant, sans évolution, sur la muqueuse digestive de ce nouvel hôte.
- **L'homme, hôte accidentel**, se contamine en ingérant du poisson cru, mariné, insuffisamment salé ou cuit contenant des L3 (merlan, hareng..). Celles-ci se fixent à la **muqueuse gastrique** ou **intestinale** provoquant une intense infiltration éosinophilique

Les hommes deviennent des hôtes accidentels en mangeant des produits de la mer crus ou mal cuits.

Anisakiasis

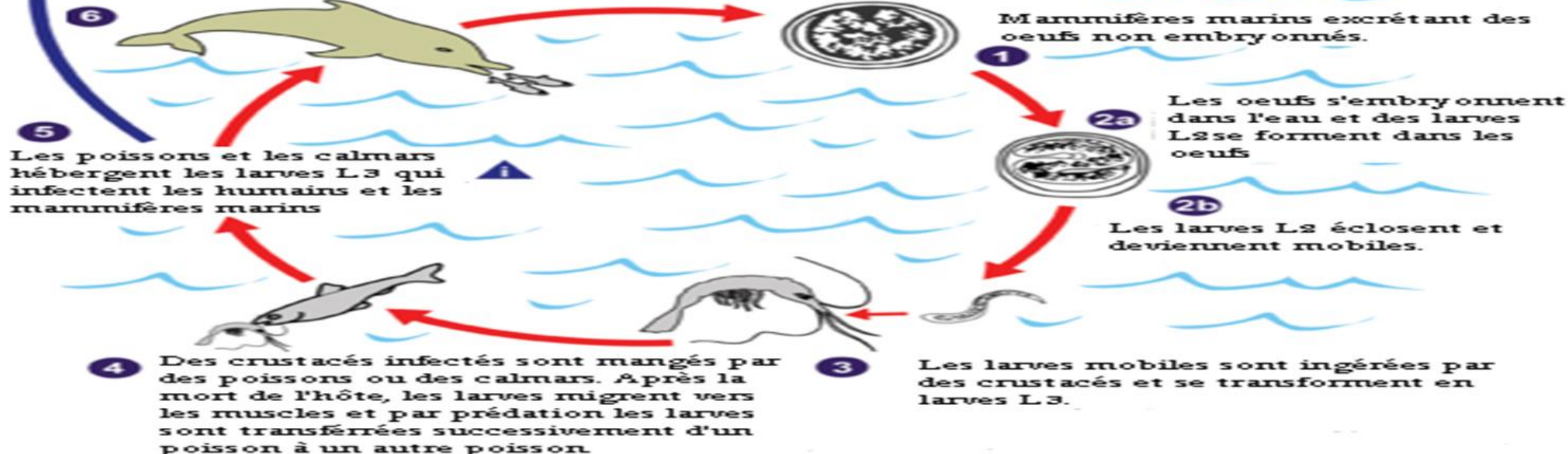
(*Anisakis simplex*, *Pseudoterranova decipiens*)

i = Etape infectieuse

d = Etape diagnostique

Le diagnostic d'anisakiase peut être fait par fibroscopie gastrique qui permet de prélever des larves de 2 cm.

Quand les poissons ou les calmars contenant des larves L3 sont ingérés par des mammifères marins, les larves muent 2 fois et deviennent des vers adultes. Les vers pondent des oeufs qui seront hébergés par des mammifères marins.



2- ANISAKIASE

II-Clinique :

- La forme gastrique: - Évolution aiguë
 - un syndrome pseudo-ulcéreux.

L'endoscopie peut mettre en évidence la ou les larves pénétrant dans la muqueuse gastrique.

- La forme intestinale: - souvent asymptomatique
 - ou évoque un syndrome tumoral, occlusif voire d'invagination

2- ANISAKIASE

III- Diagnostic:

➤ **Éléments d'orientations:**

Notion de plat infestant, HES modérée, Anémie microcytaire, Présence de sang dans les selles

➤ **Diagnostic direct:**

- Extirper et identifier les larves observées lors de **l'endoscopie gastroduodénale**.
 - **L'étude histo-pathologique** de biopsies ou de pièces opératoires montre les larves au sein d'un granulome à éosinophile.
-
- #### ➤ **Le sérodiagnostic** peut être utile. La méthode Elisa utilisant un anticorps monoclonal a montré une sensibilité et une spécificité remarquable.

2- ANISAKIASE

IV- Traitement:

- **L'extirpation chirurgicale** des larves et des granulomes larvaires est le seul traitement efficace et s'impose en cas de syndrome occlusif ou d'invagination intestinale.
- L'adjonction d'un traitement médical est souhaitable, afin d'éliminer des parasites qui auraient pu échapper (albendazole, flubendazole, mébendazole, l'ivermectine...)

V- Prophylaxie: simple et efficace

- Cuire le poisson à **65°C** (≥ 1 minute), ou le
- Congeler à **- 20°C** pendant **24 heures**.
- Une éviscération précoce et un mirage de la chair sont également préconisés pour la pêche artisanale en zone endémique.

Le syndrome de Larva migrans cutanée

Syndrome de larva migrans cutanée (dermatite ankylostomienne)

1. Définition

Correspond à la pénétration transcutanée de **larves d'ankylostomes** parasitant habituellement l'animal

Il s'agit ***d'Ankylostoma caninum*** qui évolue chez le chien

Et d'***Ankylostoma brasiliensis*** parasite du chat

2. Cycle évolutif

Comparable à celui des ankylostomes humains.

L'homme s'infeste en marchant pieds nus ou en s'allongeant sur le sol contaminé,

les larves pénètrent activement par voie transcutanée, migrent sous la peau puis meurent.



Larbish ou dermatite rampante ankylostomienne

Syndrome de larva migrans cutanée (dermatite ankylostomienne)

3. Clinique

Papule au point de pénétration, d'où part **un trajet serpigneux** correspondant au déplacement de la larve, les lésions prurigineuses disparaissent au bout **d'un mois**, elles sont localisées aux parties du corps en contact avec le sol.

4. Diagnostic

Essentiellement clinique

Eosinophilie normale

5. Traitement

Albendazole 400mg/j pdt 03j ou **Ivermectine** 200ug/kg en PU

Objectifs pédagogiques

- **Distinguer les deux sortes des syndromes de *larva migrans***
- **Connaître les différents aspects cliniques.**
- **Discuter du diagnostic devant un ensemble d'arguments.**
- **Planifier une prise en charge thérapeutique adéquate.**

MERCI DE VOTRE
ATTENTION